

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Les complications de la grossesse et la stérilité

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Ce travail dirigé évalue votre compréhension des complications de la grossesse, des causes de stérilité et des techniques de PMA, dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Suivi de grossesse et détection de complications

Une femme enceinte de 32 ans, habitant à Douala, effectue sa 4^{ème} consultation prénatale (CPN) à 28 semaines d'aménorrhée (SA). Son dossier médical indique : tension artérielle (TA) = 150 mmHg/95 mmHg (contre 120 mmHg/80 mmHg à 12 SA), protéinurie = 0,5 g/L (négative précédemment), glycémie à jeun = 1,10 g/L. Elle se plaint de maux de tête persistants et de bourdonnements d'oreilles.

1. En vous basant sur les normes cliniques, identifiez les deux complications suspectées chez cette patiente. Justifiez chaque identification par les valeurs seuils dépassées.
2. Expliquez le mécanisme physiopathologique liant l'hypertension artérielle et la protéinurie dans la complication hypertensive de la grossesse.
3. Proposez deux mesures de prise en charge immédiate et une mesure de prévention primaire pour réduire l'incidence de cette complication au niveau communautaire.

EXERCICE 2 Grossesse extra-utérine : urgence vitale

Au service des urgences gynécologiques de l'Hôpital Central de Yaoundé, une patiente de 26 ans, en aménorrhée de 8 semaines, consulte pour des douleurs pelviennes brutales unilatérales, des métrorragies noires et un malaise vagal. L'échographie pelvienne montre une cavité utérine vide, une masse annexielle de 4 cm et du liquide libre dans le cul-de-sac de Douglas (hémopéritoine). Le test de grossesse urinaire (β -hCG) est positif.

1. Nommez le diagnostic probable et citez trois facteurs de risque favorisant cette pathologie au Cameroun.
2. Pourquoi la cavité utérine est-elle vide alors que le test de grossesse est positif ? Expliquez le devenir naturel de l'embryon dans cette localisation.
3. Justifiez l'urgence chirurgicale (coélioscopie ou laparotomie) en décrivant le risque vital immédiat lié à l'hémopéritoine.

EXERCICE 3 Étude de causes d'infertilité : interprétation de données

Un centre de procréation médicalement assistée (PMA) de Douala a réalisé un bilan d'infertilité sur 200 couples consultants. Les résultats étiologiques sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Facteur étiologique	Nombre de couples	Pourcentage (%)
Facteur féminin pur (ovulatoire, tubaire, utérin)	70	35
Facteur masculin pur (spermatogénèse, voies excrétrices)	50	25
Facteur mixte (féminin + masculin)	40	20
Infertilité inexpliquée	30	15
Autres (immunologique, génétique)	10	5
Total	200	100

1. Calculez la fréquence globale de l'implication du facteur masculin (pur + mixte) et du facteur féminin (pur + mixte) dans cette série. Commentez brièvement la répartition.
2. Parmi les causes féminines, l'obstruction tubaire bilatérale séquellaire d'infections sexuellement transmissibles (IST) non traitées est majeure au Cameroun. Citez les deux principales bactéries en cause et expliquez le mécanisme de l'obstruction.
3. Chez l'homme, une oligo-asthénotératozoospermie (OATS) sévère est diagnostiquée. Citez trois causes environnementales ou comportementales fréquentes au Cameroun pouvant altérer la spermatogénèse.

EXERCICE 4 Procréation Médicalement Assistée : FIVETE et éthique

Un couple, après 5 ans d'infertilité tubaire bilatérale confirmée, bénéficie d'une Fécondation In Vitro avec Transfert Embryonnaire (FIVETE). La stimulation ovarienne a permis de prélever 12 ovocytes matures (MII). Après fécondation (ICSI), 8 ovocytes sont fécondés (2 PN). Au jour 3 (stade 8 cellules), 6 embryons sont de bonne qualité. Deux embryons sont transférés, les 4 restants sont vitrifiés.

1. Décrivez les 4 étapes principales de la FIVETE, de la stimulation ovarienne au transfert, en précisant le rôle de l'hCG exogène.
2. Calculez le taux de fécondation et le taux d'embryons de bonne qualité au jour 3 (par rapport aux ovocytes fécondés). Ces taux sont-ils dans les normes de laboratoire ?
3. Discutez de deux avantages et de deux limites éthiques majeures liées à la congélation (vitrification) des embryons surnuméraires et au sort de ces embryons en cas de séparation du couple ou de décès.

EXERCICE 5 Sensibilisation en santé reproductive : conception d'un outil

Dans le cadre de la « Semaine de la Santé de la Reproduction » organisée par le MINSANTE dans un arrondissement rural de l'Extrême-Nord, vous devez concevoir une affiche de sensibilisation ciblant les adolescentes (15–19 ans) sur la prévention des grossesses précoces et des avortements à risque.

1. Définissez le message principal (slogan) de l'affiche, clair et percutant, en français ou en langue locale (fulfulde/arabe).
2. Listez 4 informations médicales essentielles (risques maternels, foetaux, légaux) qui doivent figurer sur l'affiche pour décourager les IVG clandestines et promouvoir la contraception.
3. Proposez deux stratégies de diffusion de cet outil adaptées au contexte rural (faible alphabétisation, barrières socioculturelles) pour garantir son efficacité.